

26 - Retard de Croissance In Utero (RCIU) - Pr. ABOULFALAH

Bonjour, on va poursuivre le cours sur les souffrances fœtales. On a vu les souffrances fœtales aiguës ou l'asphyxie périnatale. Aujourd'hui, on va voir les retards de croissance in utero, appelés auparavant les souffrances fœtales chroniques.

Le retard de croissance intra-utéro représente une pathologie fréquente puisqu'il touche 5 à 10 % des grossesses. Cette situation expose à une lourde mortalité et morbidité périnatale. Il pose trois ordres de problèmes.

Le premier problème est un problème de diagnostic, aussi bien de diagnostic positif et étiologique. Le deuxième problème, c'est un problème de pronostic. Il faut établir le pronostic pour résoudre le troisième problème qui est la conduite thérapeutique.

Et puis, on va insister sur la surveillance prénatale des grossesses et la prise en charge neonatale de ces bébés fragiles. Tout d'abord, la définition. Le retard de croissance intra-utéro, il s'agit d'une diminution de la croissance fœtale ou des mensurations fœtales anormalement basses pour l'âge gestationnel et qui sont toujours reportées sur des cours de croissance d'une population témoin.

Avant, on parlait de l'hypotrophie qui est un terme beaucoup plus pédiatrique. Il s'agit d'un nouveau-né dont le poids de naissance est anormalement bas par rapport à la population témoin. L'hypotrophie, quand elle est inférieure à 10% percentile, est classée en hypotrophie modérée quand elle est entre 10% et 3%, et les hypotrophies sévères quand elle est inférieure au troisième percentile.

La souffrance fœtale chronique s'agit d'un état pathologique résultant des perturbations des échanges aussi bien nutritionnels qu'aseux entre le fœtus et la maman et qui sera responsable de l'hypotrophie fœtale. Au plan physiopathologique, la croissance fœtale dépend d'un certain nombre de facteurs génétiques intrinsèques fœtaux et aussi de facteurs nutritionnels extrinsèques qui peuvent être maternels d'origine vasculaire. Dans des situations pathologiques, il y aura des modifications histologiques et biochimiques au niveau du placenta, mais dans l'état normal, le bébé va favoriser ses organes nobles, donc il y aura une redistribution vasculaire en faveur des organes nobles, en particulier le cerveau.

Et avec le temps, on aura un ralentissement de la courbe de croissance, puis l'apparition d'une hypoxie avec acidoses qui peuvent conduire à une mort fœtale in utero. Il faut connaître la classification. On parle de deux types de retard de croissance intra-utérin.

Le retard de croissance intra-utérin désharmonieux ou asymétrique et le retard de croissance intra-utérin harmonieux ou symétrique. Le retard de croissance intra-utérin asymétrique ou désharmonieux, on va trouver un périmètre abdominal qui est plus souvent touché. Cette situation, c'est la plus fréquente, c'est 70% des cas de retard de croissance intra-utérin.

La croissance intra-utérine est la plus souvent touchée. Sa survenue au cours de la grossesse, elle est souvent tardive. L'origine est souvent maternelle.

Et le nouveau-né va avoir un poids diminué. Mais la taille est normale. Et puis, le pronostic à long terme, il est bon parce que le bébé, génétiquement, il est sain, mais la cause, il est beaucoup plus d'origine maternelle.

Et puis, il y a le retard croissance intra-hétéra de type harmonieux ou symétrique. Là, le périmètre abdominal et le périmètre céphalique sont les deux touchés. Donc, aussi bien le segment abdominal que cérébral.

Cette situation est retrouvée dans 30% des cas de retard croissance intra-hétéra. Sa survenue, elle est souvent précoce. L'origine, elle est fœtale.

Et puis, puisque le cerveau est touché, le pronostic à long terme, il sera réservé. Quelles sont maintenant les étiologies des retard croissance intra-hétéra? Il y a des causes extrinsèques d'origine maternelle et des causes intrinsèques qui sont d'origine fœtale. Dans notre contexte, les étiologies sont dominées essentiellement par les causes vasculaires et les causes essentielles.

Alors, il faut toujours chercher les facteurs favorisants, les âges extrêmes, la primiparité. Il faut s'occuper des conditions socio-économiques, les habitudes toxiques, en particulier le tabac, qui expose un risque accru de retard croissance intra-hétéra. Il faut toujours chercher s'il y a un terrain vasculaire chez la maman.

Globalement, on retrouve trois groupes d'étiologies. Les étiologies maternelles dites pré-placentaires, les étiologies d'origine placentaire, et puis on parle des étiologies post-placentaires qui sont d'origine funiculaire ou fœtale. Et puis, quand on ne trouve pas de cause directe sur le retard croissance intra-hétéra, et dit idiopathique, situation retrouvée dans 30% des cas.

Concernant les causes maternelles pré-placentaires, on retrouve essentiellement, surtout dans notre contexte marocain, les hypertensions artérielles gravidiques, dans presque 40% des cas, représentés essentiellement par la pré-eclampsie. Puis on va trouver le diabète, les néphropathies, les maladies auto-immunes, toutes les situations conduisant à une hypoxie chez la maman, les anémies, les cardiopathies, les bronchopneumopathies chroniques, quand il y a un déficit nutritionnel ou lorsqu'il y a des anomalies utérines comme, par exemple, une hypodrophie utérine ou une malformation utérine. Et puis, il ne faut pas oublier le tabagisme.

Les causes placentaires sont représentées par le placenta bas inséré, un décollement partiel du placenta, un choréangiome placentaire, c'est une tumeur bénigne qui entraîne des chaînes vasculaires qui peuvent être responsables de retard de coagulation centrale etc. Et puis, les situations où il y a des infarctus multiples au niveau du placenta. Les causes funiculaires, on peut retrouver un nœud vrai du cordon, circulaire serré du cordon, les insertions vilamenteuses du cordon, l'artère ombilicale unique et là qui est souvent associée à des malformations, c'est

pourquoi il faut être prudent et faire une échographie morphologique à la recherche des anomalies morphologiques chez le fœtus.

Et puis, il y a les causes fœtales. Donc, on retrouve les anomalies chromosomiques aussi bien au niveau du nombre que de la structure et représentées essentiellement par la trisomie 21, trisomie 18 et trisomie 13. Et puis, on peut trouver des anomalies congénitales majeures en particulier du système nerveux central, des anomalies rénales au cardiaque et puis toutes les infections materno-fœtales type cytomégalovirus, la rubéole, l'herpès, la varicelle, la syphilis, la toxoplasmose, le paludisme, la listériose.

Et puis, dans les grossesses multiples, on peut souvent avoir un retard de croissance intra-utérine. Alors, concernant le diagnostic positif, sur le plan clinique, il faut toujours chercher les circonstances de découverte, soit sur des signes fonctionnels, par exemple, une diminution des mouvements actifs fœtaux ou un développement utérin insuffisant par rapport à la gestationnelle, comme on peut trouver un retard de croissance intra-utérin lors d'une complication gravidique, en particulier la pré-eclampsie. Il faut toujours commencer par l'anamnèse, voir l'âge de la patiente, la parité, le niveau socio-économique, est-ce qu'il y a des antécédents médicaux, diabète, hypertension, les antécédents obstétricaux, par exemple, une mort fœtale antérieure, une pré-eclampsie antérieure, un retard de croissance intra-utérin.

Il faut essayer de déterminer avec exactitude la date des dernières règles, c'est très très important dans ce contexte-là, et puis étudier le dossier de la patiente, en particulier sur le déroulement de la grossesse actuelle. L'examen physique, on va retrouver une hauteur utérine diminuée, insuffisante par rapport à l'âge gestationnel, et bien évidemment, il faut faire un examen général de la patiente. Sur le plan paraclinique, c'est l'échographie obstétrique qui va déterminer, bien évidemment, le diagnostic positif, mais aussi on va avoir une idée sur le diagnostic étiologique.

Au niveau de l'échographie obstétricale, on fait bien évidemment la biométrie fœtale avec les mensurations au niveau des trois segments, en particulier la tête, par le diamètre biparital et le périmètre céphalique, le diamètre transverse de l'abdomen et le périmètre abdominal, et la longueur du fémur. Et sur ces éléments-là, on aura une estimation du poids fœtal, qu'on va rapporter sur des courbes de référence, des mensurations en fonction de l'âge gestationnel, et c'est comme ça qu'on va définir le retard de croissance intra-hétéro, soit en division standard, soit en percentiles, moins de deux divisions standards, au moins de dixième ou cinquième ou troisième percentile. L'échographie va apprécier la vitesse de la croissance fœtale, en particulier par deux mesures suffisamment espacées, au moins deux semaines, et au bout de ces mensurations là, on va classer le retard de croissance intra-hétéro en asymétrique, harmonieux ou désharmonieux, asymétrique.

Le diagnostic différentiel, c'est quelque chose de très, très important. Donc, il faut regarder s'il n'y a pas une erreur du terme. Et là, il faut chercher l'absence de contexte de retard de croissance

intra-hétéro.

La date des dernières règles, mais surtout l'échographie du premier trimestre qui nous donne avec exactitude l'âge de la gémme. Et quand on a une erreur de terme, souvent la vitesse de croissance, elle est conservée, mais bien évidemment, il faut assurer une surveillance rapprochée pour ne pas passer à côté de retard de croissance intra-hétéro. Puis, il y a les hypothèses constitutionnelles.

Là, on a l'absence de tout contexte de retard de croissance intra-hétéro. Elles sont souvent héréditaires. Il faut regarder la taille des parents.

Et puis, sur les mensurations, il y a une diminution de tout le diamètre, tous les segments. Et puis, dans l'échographie de contrôle, la vitesse de croissance, elle est toujours conservée. Sur le plan diagnostique étiologique, sur le plan clinique, donc l'amnèse, il faut chercher s'il y a des facteurs favorisants, les antécédents médicaux et aux tricots, et voir le terrain vasculaire.

Et puis, un examen physique, la tension artérielle, le poids, les bandes lettrées actives, regarder s'il y a une pâleur, la présence de dents, et faire un examen général. Au plan paraclinique, un bilan biologique, il faut toujours demander à Gopaj Resus, l'hémogramme, un bilan rénal, un bilan hépatique, l'URSMI, et une protéinurie de 24 heures. Et un bilan infectieux, en particulier par la sérologie, la rubeole, la toxoplasmose, la syphilis et la CMV, la cytomygalovirus.

L'échographie morphologique, c'est quelque chose de très, très important à la recherche des malformations du système nerveux central, des malformations au niveau du rein, du cœur, du squelette. Il faut étudier le placenta. La quantité de liquide amniotique, c'est quelque chose de très important.

On a toujours une diminution du liquide amniotique, aminogamnose, voire anamnose, surtout quand il s'agit d'un retard d'origine vasculaire. Il faut étudier le cordon ombilical, et puis avec cette échographie, couplée au Doppler, on va étudier le Doppler utérin, un Doppler utérin pathologique qui nous oriente vers une cause maternelle, vasculaire. Et puis, il faut étudier le Doppler ombilical pour le bien-être fœtal.

Et puis, il y a le cariotype fœtal par un prélèvement du liquide amniotique, ce qu'on appelle le cariotype fœtal. Il faut étudier le cariotype fœtal pour avoir le résultat du cariotype le plus tôt possible. Et puis, une fois le diagnostic posé, il faut faire un bilan du bien-être fœtal sur le plan clinique par les mouvements actifs du fœtus.

L'autorutérine est sur la perception des bruits du cœur fœtal. Et c'est surtout l'échographie qui va préciser le type de retard de croissance intra-hétéro, sa sévérité et puis elle va étudier la scénétique de la croissance fœtale. Elle va faire un grading placentaire, mesurer la quantité du liquide amniotique et va étudier la réactivité et la vitalité fœtale.

Toujours dans l'étude du bien-être fœtal, c'est par le Doppler ombilical. Il faut voir le Doppler ombilical, c'est altéré et complété par un Doppler cérébral. Et il y en a d'autres sites de mesure au niveau du Doppler, en particulier actuellement le ductus vénosus.

L'enregistrement du rythme cardiaque fœtal, c'est très très important dans ces contextes de retard de croissance intra-utérin et on va analyser le rythme de base, les oscillations présents au nom des accélérations et présents au nom du ralentissement et puis va étudier le score biophysique de Manning. Donc c'est un score qui contient 5 paramètres cotés de 0 au 2 et notés sur 10. Ces paramètres-là, c'est la quantité de liquide amniotique, les mouvements fœtaux, les mouvements respiratoires du fœtus, le tonus fœtal et puis un cinquième élément électrique qui est l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal pendant une période de 30 minutes.

En présence d'un rythme douteux, d'un score douteux, on peut rendre sensible ce test, ce qu'on appelle le test de tolérance à la contraction utérine, stress test. Donc on fait une perfusion d'ocytocine pour déclencher des contractions utérines et voir les répercussions de ces contractions sur le bébé. Alors maintenant, quelle est la conduite obstétrique? Donc il y a des mesures générales.

On peut proposer une interruption médicale de grossesse quand il y a des malformations graves, létales, non curables. Il y en a en fonction du contexte psychologique de la patiente. On peut proposer l'abandon fœtal, mais ça ne se fait plus.

Il faut avoir une conduite active et puis proposer à un moment donné l'extraction fœtale pour sortir ce bébé de cette ambiance nocive. Mais l'enjeu est grand entre le risque d'extraction fœtale avec la prématurité ou laisser le bébé in utero avec le risque de mort fœtale in utero. En général, au-delà de 36 semaines d'aménorrhée, on fait une extraction de principe et moins de 36 semaines d'aménorrhée, on propose une surveillance intensive par le rythme cardiaque fœtal, par l'échographie avec couplé odopère et on propose des critères d'extraction avant le terme quand il y a des critères électriques, par exemple des ralentissements à un rythme qui devient à réactif et que le bébé ne gagne plus en termes de poids in utero ou quand vous avez un odopère ombilical et cérébral très altéré, il vaut mieux extraire ce bébé.

Alors concernant les modalités d'extraction, si souvent par césarienne, mais quand le stress teste les biens, on peut proposer un déclenchement du travail et bien évidemment à la naissance il faut qu'il y ait une prise en charge néonatale correcte. Concernant le pronostic, le pronostic maternel n'est pas engagé, mais il y a un taux élevé de césarienne, mais surtout le pronostic périnatal qui sera fonction de l'étiologie et du moment de survenue dans la grossesse, risque de mort fœtale in utero, risque de prématurité, risque de souffrance fœtale aiguë au moment du travail, on peut trouver des malformations congénitales et ce bébé-là est exposé au risque de décès néonatale ou à long terme un handicap psychomoteur et intellectuel. Est-ce qu'il y a une prévention? Oui, on peut proposer de l'aspirine chez des patientes qui ont un thérapeute vasculaire, qui ont des antécédents chargés.

On peut proposer aussi le corticoïde surtout dans les maladies auto-immunes, les anticoagulants quand il y a une thrombophilie chez la patiente. Il faut savoir dépister les femmes à risque, en particulier par le Doppler utérin au deuxième trimestre, voire au premier trimestre. Une surveillance prénatale correcte par une oncographie biométrique et puis une surveillance appropriée des retards de croissance intra-utérins pour proposer une extraction avant le décès ou avant l'installation des séquelles.

Et puis l'extraction fœtale à terme, c'est le terme le plus important, et avoir une prise en charge néonatale adéquate.